

Por que não nos dobramos ao manual

A disputa pelo controle da classificação, a estrutura que foi retirada em 1980, e a tábua de tradução da Virtologia

O QUE ESTE CAPÍTULO FAZ

Todo sistema que propõe uma nosologia própria deve ao leitor duas explicações: **por que não adota a existente e como conversar com ela**. Este capítulo dá as duas.

A primeira parte é histórica e documental. Sustenta que a passagem do diagnóstico estrutural para o diagnóstico descritivo, ocorrida em 1980 com o DSM-III, não foi apenas um avanço metodológico: foi também um episódio de disputa profissional pelo controle do sistema de classificação — tese que não é opinião desta obra, mas leitura publicada em periódicos revisados por pares, inclusive no *American Journal of Psychiatry*, e que aqui se apresenta com autores e datas.

A segunda parte é construtiva. Apresenta a definição virtológica de transtorno e oferece uma **tábua de tradução** — o que são, lidas pela estrutura desta obra, a neurose, a psicose, a perversão e as categorias de personalidade a que o leitor está habituado. A tábua existe para facilitar o trânsito, não para substituir a estrutura. **Traduzimos sem nos converter**, e o capítulo termina explicando a diferença.

§ 1 Uma pergunta que o leitor tem o direito de fazer

Se o leitor chegou até aqui, encontrou uma arquitetura completa: dois sistemas neurofuncionais como raiz, trinta e três virtudes como competências cultiváveis, cinquenta e uma necessidades em cinco grupos, sete faixas de evolução, vinte Leis da Vida, uma equação de fluxo. E encontrará, nos capítulos seguintes, uma classificação de transtornos construída sobre isso.

A pergunta é inevitável, e é justa: *por que não usar simplesmente o manual que o mundo inteiro usa?* Existe uma classificação internacional, adotada por hospitais, tribunais, seguradoras e universidades. Propor outra parece, à primeira vista, ou arrogância ou ignorância.

A resposta tem duas partes, e a primeira delas é histórica. **O manual que o mundo usa hoje foi construído, em 1980, de modo a não poder receber afirmações do tipo que esta obra faz**. Não por hostilidade a esta obra, que não existia; mas porque a reforma daquele ano retirou da nosologia o campo em que uma afirmação sobre causa poderia ser inscrita. Quem tem uma tese etiológica e tenta acomodá-la ali não está sendo prudente: está entregando aquilo que tem de próprio na porta de entrada.

§ 2 O que havia antes: o diagnóstico que perguntava pela estrutura

A clínica que precedeu o manual descritivo não perguntava quais sintomas o paciente apresentava. Perguntava qual era a **posição do sujeito** — e a resposta admitia um número pequeno e fechado de possibilidades. Freud estabeleceu a distinção entre neurose e psicose e tratou a perversão como destino pulsional próprio; Lacan formalizou a tríade como sistema, definindo cada estrutura pelo mecanismo que a constitui — o recalque, a forclusão, o desmentido.

A propriedade decisiva desse sistema, e a que se perdeu, é que **a estrutura não varia com o sintoma**. Um mesmo sujeito pode apresentar fobia, obsessão, conversão e depressão ao longo da vida sem mudar de estrutura, porque a estrutura não é o que aparece — é o modo como o aparelho se organizou diante de uma operação fundadora. O diagnóstico era etiológico e prognóstico ao mesmo tempo, e a conduta decorria dele.

UMA PRECISÃO QUE FORTALECE O ARGUMENTO

A tríade neurose–psicose–perversão como sistema formalizado é mais especificamente lacaniana do que universalmente psicanalítica. Isso poderia sugerir que o diagnóstico estrutural fosse peculiaridade de uma escola. Não é — e a prova está do outro lado do Atlântico.

Otto Kernberg formulou, entre 1967 e 1975, a teoria da *organização de personalidade* em três níveis — neurótica, borderline e psicótica —, definidos por três critérios operacionais: grau de integração da identidade, tipo de defesa predominante e capacidade de prova de realidade. É também um diagnóstico estrutural de três posições, construído na tradição das relações objetais, independentemente de Lacan.

Duas tradições distintas, partindo de pressupostos diferentes, chegaram à mesma forma de diagnosticar. Quando o DSM-III a retirou, não retirou a idiosincrasia de uma escola francesa: **retirou a forma estrutural de diagnosticar**.

§ 3 1980: o ano em que a estrutura saiu do manual

O DSM-I, de 1952, e o DSM-II, de 1968, eram manuais finos, de definições em parágrafo, atravessados pela linguagem psicodinâmica — o primeiro com a terminologia das "reações", de Adolf Meyer, o segundo mantendo a "neurose" como categoria organizadora explícita. O DSM-III, de 1980, foi outra coisa: critérios operacionais, sistema multiaxial, e a declaração de ser **ateórico quanto à etiologia**.

É preciso reconhecer, antes de criticar, que a crise que produziu essa reforma era real. O Projeto Diagnóstico EUA–Reino Unido, publicado por Cooper e colaboradores em 1972, mostrou que psiquiatras de Nova York diagnosticavam esquizofrenia em proporção muito superior à de seus colegas de Londres diante de pacientes comparáveis. Os estudos de concordância da época encontravam coeficientes baixos para muitas categorias. A antipsiquiatria havia tornado respeitável, no debate público, a tese de que a doença mental era construção social. E, em 1973, a desclassificação da homossexualidade — decidida em votação — demonstrou publicamente que a nosologia psiquiátrica era negociável por assembleia, o que, para uma disciplina que reivindicava estatuto médico, foi catástrofe de legitimidade.

Some-se a isso um dado que raramente aparece nas histórias oficiais e que é decisivo: ao longo daquela década, seguradoras norte-americanas passaram a restringir a cobertura de tratamentos psiquiátricos, alegando imprecisão diagnóstica e duração indefinida. **Uma nosologia sem fronteiras claras é impossível de faturar.** E o formato de critérios discretos que resolvia o problema científico era exatamente o formato que resolvia o problema comercial. Não é preciso supor má-fé para explicar a convergência: basta observar que a solução disponível servia às duas necessidades ao mesmo tempo.

Marco	Ano	O que estabeleceu
Crítérios de Feighner	1972	Primeira lista de critérios operacionais, produzida na Universidade Washington, em Saint Louis. Tornou-se um dos artigos mais citados da psiquiatria.
Research Diagnostic Criteria	1978	Spitzer, Endicott e Robins expandem o modelo. Protótipo direto do DSM-III.
O "credo neokraepeliniano"	1978	Klerman enuncia o programa do grupo: a psiquiatria é ramo da medicina; há fronteira entre normal e doente; existem doenças mentais discretas; a ênfase recai sobre o biológico.
Força-tarefa do DSM-III	1974–1980	Spitzer preside. A composição privilegia pesquisadores de orientação empírica; a representação psicanalítica é minoritária.

Quadro 1 — A sequência que produziu a reforma.

O texto de Klerman merece ser lido pelo que é: **um manifesto**. Não a descrição neutra do estado da ciência, mas a enunciação de um programa — e de um programa que define a psiquiatria de modo a deslocar do centro qualquer abordagem cuja unidade de análise não seja a doença discreta.

§ 4 A batalha da neurose, e por que o parêntese foi uma derrota

O episódio está documentado por um dos próprios protagonistas. Bayer e Spitzer publicaram em 1985, nos *Archives of General Psychiatry*, a história da controvérsia; Hannah Decker a reconstruiu em detalhe em *The Making of DSM-III*, de 2013; e Mitchell Wilson a analisou no artigo de 1993 do *American Journal of Psychiatry*.

O rascunho eliminava a "neurose". A Associação Psicanalítica Americana reagiu com força, e a disputa ameaçou a aprovação do manual em assembleia. Spitzer negociou: os termos neuróticos foram admitidos **entre parênteses**, ao lado das denominações descritivas.

A ANATOMIA DA DERROTA

A concessão preservou a palavra e retirou a função. "Neurose", no DSM-II, era um **princípio de organização**: dizia o que aqueles quadros tinham em comum e por que se agrupavam. No DSM-III tornou-se sinônimo tolerado, apenso a categorias organizadas por outro critério.

A partir dali, a fobia, a obsessão e a ansiedade generalizada deixaram de ser formas de uma mesma estrutura e passaram a ser entidades separadas, com critérios próprios, comorbidade calculável entre si e histórias naturais independentes. **O que se perdeu não foi um termo: foi a afirmação de que havia ali uma unidade** — e é exatamente esse tipo de afirmação que a Virtologia faz quando diz que famílias inteiras de comportamento derivam de um mesmo sistema neurofuncional.

§ 5 O ponto lógico: "ateórico" não existe

A declaração de ateoricidade é apresentada, então e agora, como gesto de humildade: na ausência de conhecimento causal estabelecido, descreve-se sem afirmar causa. A formulação é elegante e a sua neutralidade é impossível.

Um sistema que exclui a etiologia da definição não trata todas as teorias igualmente. **Prejudica seletivamente aquelas cuja contribuição é etiológica, e favorece aquelas cujo objeto é a descrição de superfície.** A psicanálise não afirma que a fobia e a obsessão se parecem; afirma que derivam do mesmo mecanismo. A Virtologia não afirma que a vaidade e a reatividade à crítica se parecem; afirma que ambas derivam da valoração de posição referida ao self. Retirada a etiologia da nosologia, essas afirmações não foram refutadas — **perderam onde ser inscritas**. O formulário deixou de ter campo para elas.

E a ateoricidade nunca foi cumprida. O sistema multiaxial, a separação entre eixos, o próprio conceito de transtorno como síndrome com curso e desfecho: tudo isso é teoria, e teoria de um tipo determinado — kraepeliniana. O DSM-III não removeu a teoria. **Substituiu uma teoria por outra e declarou a segunda como ausência de teoria.** Esta é, tecnicamente, a operação que precisa ser nomeada, e ela não depende de atribuir intenção a ninguém: é uma constatação de lógica.

§ 6 A disputa pelo controle da classificação

Chega-se ao ponto que dá título a esta seção, e que o leitor encontrará formulado com todas as letras na literatura acadêmica.

Andrew Abbott, em *The System of Professions*, de 1988, estabeleceu o que hoje é posição padrão em sociologia das profissões: profissões não competem por prestígio em abstrato — competem por **jurisdição**, o direito reconhecido de exercer determinado trabalho. E a arma decisiva nessa competição é o **controle do sistema de classificação**. Quem define as categorias do problema define, no mesmo gesto, quem está qualificado a tratá-lo.

Aplicado ao caso: uma nosologia organizada por doenças discretas de curso e desfecho define um problema médico, e a competência médica torna-se o critério de habilitação. Uma nosologia organizada por estruturas subjetivas define um problema de outra ordem, e a formação em análise torna-se o critério. **Nenhum grupo precisa agir de má-fé para que isso ocorra**: basta que cada um promova, com sinceridade, a classificação que torna a sua própria competência necessária. A convergência entre convicção e interesse é o caso normal, e é justamente por isso que a tese é forte — ela não acusa, descreve.

Componente da tese	Formulação	Quem sustenta
Jurisdição profissional	Nos anos 1970 a psiquiatria disputava mercado com psicólogos e assistentes sociais, que ofereciam psicoterapia a custo menor. O diferencial defensável era a medicina; remodelar a nosologia era remodelar a profissão.	Wilson (1993, <i>American Journal of Psychiatry</i>); Mayes e Horwitz (2005); moldura em Abbott (1988)
Retórica de cientificidade	As alegações de confiabilidade do DSM-III foram apresentadas com força superior ao que os ensaios de campo sustentavam.	Kirk e Kutchins, "The Selling of DSM" (1992)
Reembolso	Categorias discretas e verificáveis por lista são condição de faturamento em sistema de seguros.	Mayes e Horwitz (2005)
Indústria farmacêutica	Diagnósticos discretos correspondem a indicações regulatórias discretas; a expansão de categorias acompanha a de mercados.	Healy (1997); Whitaker (2010)
Conflito de interesse	Proporções substanciais dos painelistas do DSM-IV e do DSM-5 mantinham vínculos financeiros com a indústria.	Cosgrove e Krimsky (2006; 2012)
Medicalização do normal	O deslocamento produziu expansão de fronteiras diagnósticas sobre a experiência comum.	Horwitz (2002); Horwitz e Wakefield (2007); Lane (2007); Frances (2013)

Quadro 2 — A tese da disputa de jurisdição, com sustentação identificada.

Vale registrar quem são alguns desses críticos, porque o leitor pode supô-los marginais e eles não são. **Allen Frances** presidiu a força-tarefa do DSM-IV e tornou-se crítico público do DSM-5. **Thomas Insel**, dirigindo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados

Unidos, declarou em 2013 que o manual carecia de validade e reorientou o financiamento do instituto para fora de suas categorias, criando o programa RDoC. A **Divisão de Psicologia Clínica da Sociedade Britânica de Psicologia** emitiu, no mesmo ano, declaração institucional pedindo mudança de paradigma para longe do modelo de doença, e publicou em 2018 uma alternativa formal, o *Power Threat Meaning Framework*. Não se trata de dissidência de rodapé: trata-se de ex-presidentes de força-tarefa, diretores de institutos nacionais e sociedades profissionais inteiras.

§ 7 O segundo fechamento: os modelos de traços

O DSM-III retirou a etiologia mas manteve categorias, que ainda podiam, com esforço, receber leitura estrutural por fora do manual. O movimento seguinte foi de outra natureza.

O Modelo Alternativo para Transtornos da Personalidade, na Seção III do DSM-5, e o modelo de cinco domínios da CID-11 adotaram como espinha dorsal um instrumento derivado da **tradição léxico-fatorial da psicologia diferencial** — a linhagem que vai de Allport e Odbert a Cattell, Tupes e Christal, Norman, Goldberg, Costa e McCrae, e que desemboca no PID-5 de Krueger e colaboradores.

Essa tradição tem genealogia própria e integralmente alheia a qualquer teoria estrutural. Nasceu do dicionário e da análise fatorial, e **não dispõe de vocabulário para representar uma afirmação etiológica** — não por hostilidade, mas por construção. Um fator é um sumário de covariância entre descritores. Não há, nele, onde inscrever a proposição de que a vaidade, a comparação e a reatividade à crítica derivam de uma mesma operação neural.

UMA DISTINÇÃO QUE O LEITOR RIGOROSO EXIGIRÁ

É sólido afirmar que a adoção do modelo léxico-fatorial **fecha institucionalmente a porta** a qualquer nosologia etiológica. Essa consequência é estrutural e verificável, independentemente da intenção de quem adotou o modelo.

Já afirmar que a escolha foi *deliberadamente* feita para excluir esta ou aquela escola é alegação sobre intenção, e esta obra não tem como confirmá-la. A explicação mais simples é também suficiente: o modelo de traços dispunha do maior acervo psicométrico acumulado, e a decisão seguiu a evidência disponível **dentro de um campo cujas fronteiras já haviam sido redesenhadas em 1980**. A exclusão já estava consumada; o modelo dimensional apenas a consolidou. Esta formulação é mais modesta e, precisamente por isso, muito mais difícil de refutar.

§ 8 Onde esta crítica se sustenta, e onde ela excede

Esta obra escreve com as portas abertas, e não faria sentido abandonar esse método justamente onde a tentação de exagerar é maior. Convém dizer com precisão o que a evidência sustenta e o que não sustenta — porque **uma versão exagerada da tese é mais fácil de refutar do que a versão exata**, e quem a sustenta em debate público precisa da exata.

O que se sustenta

- Que a disputa de jurisdição profissional foi motor documentado da reforma, sustentado em periódicos revisados por pares e explicado por teoria sociológica estabelecida.
- Que a declaração de ateoricidade não é neutra e prejudica seletivamente programas etiológicos. Isto é ponto de lógica, não de história, e não depende de intenção.
- Que reembolso e indústria exerceram pressão convergente na direção de categorias discretas.

O que não se sustenta

- Que tenha havido conspiração deliberada para eliminar a psicanálise. A explicação por convergência de interesses é mais econômica, melhor documentada e — este é o ponto — mais difícil de refutar, porque não exige provar a intenção de ninguém.
- Que a crise de confiabilidade fosse pretexto. Era real. E a psicanálise institucional daquele momento tinha vulnerabilidades próprias: formulações de difícil falsificação, ausência de dados de concordância entre avaliadores, resistência prolongada à pesquisa de desfecho. **Parte do terreno foi perdida por não ter sido defendida com os instrumentos que a época já exigia** — e esta obra registra isso como advertência a si mesma, não como acusação a terceiros.

§ 9 A prova de que a estrutura podia ter ficado

Aqui está o argumento decisivo, e ele não é retórico: é uma demonstração por existência.

Se a remoção do diagnóstico estrutural tivesse sido exigência da ciência — se a estrutura fosse, por natureza, impressionística e não mensurável —, então nenhum sistema estrutural teria conseguido alcançar confiabilidade aceitável entre avaliadores. Ocorre que três conseguiram.

Sistema	Origem	O que demonstrou
OPD e OPD-2	Grupo alemão de Diagnóstico Psicodinâmico Operacionalizado, 1996; 2ª ed. 2006	Operacionalizou eixos psicodinâmicos — entre eles um eixo de estrutura — em critérios, com manual de treinamento, escalas ancoradas e estudos de concordância entre avaliadores.
PDM e PDM-2	Manual Diagnóstico Psicodinâmico, 2006; 2ª ed. 2017, coordenada por Lingiardi e McWilliams	Construiu classificação psicodinâmica completa, com eixos de personalidade, funcionamento mental e experiência subjetiva, como alternativa declarada ao manual descritivo.

Sistema	Origem	O que demonstrou
Entrevista estruturada de Kernberg	Tradição das relações objetais	Operacionalizou os três níveis de organização de personalidade — neurótica, borderline, psicótica — em entrevista com critérios avaliáveis.

Quadro 3 — Sistemas estruturais operacionalizados.

A CONSEQUÊNCIA LÓGICA

Se o diagnóstico estrutural **pode** ser operacionalizado e alcançar confiabilidade aceitável, então a sua remoção do manual em 1980 não foi imposição da ciência. **Foi escolha entre programas de pesquisa** — e escolhas têm ônus de justificação, que recai sobre quem as fez.

É este o fundamento pelo qual a Virtologia mantém estrutura própria sem se colocar fora da ciência. Não estamos reivindicando o direito de sermos impressionistas. Estamos afirmando que estrutura e rigor são compatíveis, porque outros já demonstraram que são — e assumindo, em consequência, a obrigação de produzir os mesmos dados que eles produziram. **Um sistema estrutural com kappa publicado não pode ser descartado como impressionista.**

§ 10 A definição virtológica de transtorno

Posta a razão da recusa, cabe enunciar o que se põe no lugar. E o essencial é notar que a Virtologia não diverge do manual apenas nas categorias: **diverge no eixo que define o que é um transtorno.**

Sistema	O que define o transtorno	Unidade de medida
DSM, desde 1980	Presença de número suficiente de sintomas de uma lista, por tempo determinado	Contagem de sintomas
Modelos de traços — DSM-5-TR Seção III, CID-11	Extremidade desadaptativa num fator de personalidade, mais gravidade	Posição na distribuição do traço
Virtologia	Excesso de couraça sobre uma raiz neurofuncional, produzindo desalinhamento com as Leis da Vida e desequilíbrio das Necessidades, com custo mensurável nas Grandes Áreas da vida	Grau de ocupação da vida pela defesa

Quadro 4 — Três eixos definidores distintos.

A formulação completa, tal como esta obra a sustenta, é a seguinte. **Um transtorno de personalidade é um excesso de defesa.** A couraça ergueu-se sobre uma das duas raízes — a valoração de posição, no Sistema Neurofuncional do Orgulho, ou a arbitragem entre o self e o outro, no Sistema Neurofuncional do Egoísmo —, moldada pelo temperamento e inscrita por uma história, na ausência da virtude que teria permitido atravessar a dor sem erguê-la.

Dessa couraça decorrem três consequências mensuráveis, e é a soma delas que constitui o quadro clínico. A primeira: **o desalinhamento com as Leis da Vida** — o fator LV da equação do fluxo desce, e com ele o produto inteiro, porque a equação é multiplicativa. A segunda: **o desequilíbrio das Necessidades** — grupos inteiros passam a operar em carência crônica ou em excesso patológico, e necessidade em desequilíbrio não fica quieta: soma-se à Falta e produz sintoma. A terceira: **a ocupação progressiva das Grandes Áreas** — a vitrine perde focos, e o número de áreas apagadas é a medida direta da gravidade.

POR QUE ESTE EIXO RESOLVE A QUESTÃO DO FUNCIONAL E DO DISFUNCIONAL

A pergunta que o manual descritivo não responde bem — quando um neurótico é funcional e quando deixa de ser — encontra aqui resposta natural, porque **o eixo virtológico é contínuo por construção.** A defesa não é presente ou ausente: ela ocupa mais ou menos da vida.

Um indivíduo pode operar com couraça reconhecível e nenhuma área comprometida — e é funcional, sem que a couraça deixe de existir. Outro, com a mesma configuração, tem seis áreas apagadas — e é disfuncional, sem que a configuração seja outra. **A diferença não é de espécie: é de quanto a defesa já ocupou.**

Registre-se que a CID-11 chegou, por via estatística, a conclusão convergente: ao pôr a gravidade como classificação primária, antes dos domínios, reconheceu que a fronteira entre funcional e disfuncional é contínua. Convém reivindicar essa convergência, e não tratá-la como adversária.

§ 11 Tábua de tradução I — as três estruturas clássicas

O leitor formado na clínica psicanalítica perguntará onde ficam, nesta arquitetura, a neurose, a psicose e a perversão. A resposta exige uma advertência prévia, e ela é de honestidade.

ADVERTÊNCIA SOBRE O ESTATUTO DESTA TÁBUA

O que segue é **correspondência proposta, e não identidade**. As estruturas clássicas foram formuladas a partir de uma teoria do sujeito e da linguagem que não é a desta obra; traduzir não é demonstrar equivalência. A tábua serve ao trânsito do leitor, e cada linha admite objeção legítima de quem opera na tradição de origem.

A honestidade exige, além disso, uma delimitação de alcance que esta obra assume sem constrangimento: **a correspondência é forte para a neurose, defensável para a perversão e fraca para a psicose** — e a seção 13 explica por quê.

Estrutura clássica	Mecanismo que a define	Leitura virtológica proposta
Neurose	Recalque. A lei está inscrita, e o sujeito é dividido por ela.	Couraça erguida sobre estrutura formada. Há EU em construção, e é ele que sofre da própria defesa — a marca clínica da neurose é o sujeito em conflito consigo. Origem predominante: o mal-vivido. Faixa típica: Pré-Desenvolvimento a Consciência Parcial, onde a persona domina mas o EU já emergiu e disputa o comando. É o território da quase totalidade das categorias dos Transtornos da Valoração de Posição e dos Transtornos da Arbitragem Self–Outro.
Perversão	Desmentido. A lei é conhecida e simultaneamente negada.	Configuração em que a norma é registrada com clareza e sistematicamente descontada no cálculo — não ignorada por desconhecimento, mas computada e vencida pela vantagem própria. Corresponde ao núcleo do Transtorno de Vantagem Transgressiva, na raiz do Egoísmo, com o outro constituído como variável e não como sujeito. Faixa típica: Primitivo a Sensação.
Psicose	Foraclusão. A operação fundadora não se inscreveu.	Correspondência fraca e parcial. O conceito virtológico mais próximo é o do não-vivido levado ao radical — estrutura que jamais se formou por ausência da experiência que a formaria. Mas a Virtologia NÃO oferece teoria da falha de prova de realidade, que é o núcleo clínico da psicose. Ver a seção 13.

Quadro 5 — Correspondência proposta com as estruturas clássicas.

§ 12 Tábua de tradução II — as categorias de personalidade

O leitor formado na nosologia descritiva perguntará onde ficam o narcisista, o histriônico, o borderline. A tábua abaixo responde, com a mesma advertência: são correspondências de trânsito, e várias delas são imperfeitas — o que se registra em vez de se disfarçar.

Categoria habitual	Leitura virtológica	Qualidade do ajuste
Narcisista, tipo grandioso	Transtorno de Exibição de Valor em apresentação exibida, frequentemente composto com Imposição Hierárquica. Raiz: Orgulho. Virtude nuclear ausente: Humildade.	Boa
Narcisista, tipo vulnerável	Transtorno de Exibição de Valor em apresentação dissimulada, composto com Reatividade à Ameaça de Posição. Mesma raiz, mesma virtude nuclear, prognóstico pior.	Boa — e a distinção exibido/dissimulado da Virtologia captura a divisão que a nosologia descritiva teve dificuldade em acomodar
Histriônico	Transtorno de Exibição de Valor sobre temperamento de extroversão alta e intensidade emocional alta. A categoria descritiva confunde a operação com o temperamento que lhe dá forma.	Razoável — a Virtologia separa o que a categoria mistura
Antissocial ou dissocial	Transtorno de Vantagem Transgressiva, frequentemente composto com Não-Recrutamento Empático. Raiz: Egoísmo. Virtude nuclear ausente: Abnegação.	Boa
Obsessivo-compulsivo de personalidade	Transtorno de Controle Protetivo, quando a ordem protege a autoimagem, ou Imposição de Ordem Própria, quando serve à paz do self contra o outro. A categoria descritiva não distingue os dois.	Boa, com ganho de resolução
Esquivo	Reatividade à Ameaça de Posição em apresentação dissimulada, com evitação de contextos de avaliação.	Parcial
Esquizoide	Não-Recrutamento Empático, quando há hiporrecrutamento genuíno da rede de empatia.	Parcial — a categoria descritiva agrega retraimentos de origem heterogênea
Borderline	Não corresponde a categoria única. Configuração mista, tipicamente Reatividade à Ameaça de Posição com Defesa Agressiva do Self, sobre difusão de identidade.	Fraca — ver nota abaixo
Dependente	Sem correspondência satisfatória na taxonomia atual.	Ausente — lacuna reconhecida

Quadro 6 — Correspondência proposta com as categorias de personalidade habituais.

A linha do borderline merece nota, porque é onde a tábua mais claramente falha, e a falha é instrutiva. O núcleo daquela categoria — a difusão de identidade — é um problema de **formação de estrutura**, e não de excesso de defesa sobre estrutura formada. É precisamente o objeto do nível intermediário de Kernberg, que existe para dar conta de um

funcionamento que não é neurótico nem psicótico. Uma nosologia construída sobre excesso de couraça captura mal aquilo cujo problema é a couraça não ter chegado a organizar-se. Registra-se a limitação em vez de forçar o encaixe.

§ 13 O que a Virtologia não reivindica

Nenhum sistema é forte por reivindicar tudo. É forte por saber onde termina — e por dizê-lo antes que o crítico o descubra.

- **A Virtologia não oferece teoria da psicose.** A arquitetura desta obra trata do excesso de defesa na estrutura da personalidade, e o seu instrumento é a virtude como competência neurológica. A falha de prova de realidade que constitui o núcleo clínico da psicose não é fenômeno dessa ordem, e nada nesta obra dá tração sobre ela. **A nosologia virtológica classifica organização de personalidade, e não transtornos psicóticos**, que permanecem inteiramente no campo da psiquiatria e da nosologia vigente.
- **A Virtologia não substitui a classificação internacional para fins administrativos.** Laudo, parecer, prontuário, faturamento e epidemiologia operam em CID, e devem continuar operando. A tábua de tradução existe para que o virtólogo saiba codificar sem abandonar o que pensa.
- **A Virtologia não reivindica supremacia psicométrica já demonstrada.** Reivindica superioridade explicativa e operacional — dizer de onde vem e o que fazer. A superioridade preditiva é hipótese a testar, e o protocolo de validação está publicado no manual próprio.
- **A Virtologia não está isenta do argumento que dirige aos outros.** Uma escola que forma, certifica e credencia tem, ela também, interesse na existência da sua categoria. Isso não invalida nada — interesse e verdade são independentes, e foi exatamente esse o ponto contra os neokraepelinianos. Mas obriga a que a defesa desta obra se apoie no que a distingue verificavelmente, e não na denúncia do interesse alheio. **Quem vence por denunciar interesse perde quando o interesse é apontado de volta; quem vence por dado, não.**

§ 14 A regra da casa: traduzir sem se converter

Resta enunciar a regra prática que decorre de tudo isto, e que governa o uso das tábuas deste capítulo.

O virtólogo **traduz** para conversar com o hospital, com o tribunal, com o convênio e com o colega formado em outra tradição. Traduzir é competência profissional, e recusá-la seria entregar o campo administrativo sem disputá-lo — que foi, como este capítulo mostrou, parte do erro histórico da psicanálise institucional.

Mas o virtólogo **não se converte**. A tábua vai da estrutura virtológica para a categoria alheia, e não o contrário. A pergunta clínica que abre um atendimento não é *qual categoria da CID este paciente preenche* — é *qual raiz, que grau de ocupação da vida, qual virtude ausente, quais necessidades em desequilíbrio, e de que origem*. A categoria da CID é o que se escreve no campo do formulário depois de a pergunta ter sido respondida.

A FORMULAÇÃO QUE SUSTENTA ESTA POSIÇÃO EM QUALQUER DEBATE

Não: "o manual foi feito para tirar a psicanálise, é mercado". Essa formulação exige prova de intenção e será respondida com a crise de confiabilidade, que foi real.

Sim: "a reforma de 1980 resolveu um problema real por um caminho entre vários possíveis, e o caminho escolhido foi também o que remedicalizava a profissão num momento de disputa de jurisdição. Que o OPD-2, o PDM-2 e o instrumento de Kernberg tenham depois operacionalizado o diagnóstico estrutural com confiabilidade aceitável demonstra que a estrutura não precisava ter sido removida para que houvesse rigor. A remoção foi escolha, e escolhas têm ônus de justificação — que recai sobre quem as fez, e não sobre quem as recusa."

A segunda concede tudo o que é verdadeiro do lado contrário e, exatamente por isso, não deixa onde ser atacada. **É esta a posição desta obra.**

Dr. Eduardo Casarotto

Mantemos estrutura própria não por desconhecer o manual, mas por conhecer a sua história. Um sistema construído para não receber afirmações etiológicas não pode acolher uma tese sobre a origem do transtorno — e quem a entrega na porta de entrada não conserva nada do que veio dizer. Traduzimos para conversar; não nos convertemos para ser aceitos. E assumimos, com isso, a obrigação que a recusa impõe: produzir os dados de confiabilidade e de validade que tornam uma estrutura indescartável. É o que o OPD-2 fez na Alemanha, e é o que nos cabe fazer aqui.

Referências deste capítulo

- ABBOTT, Andrew. *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- BAYER, Ronald; SPITZER, Robert L. Neurosis, psychodynamics, and DSM-III: a history of the controversy. *Archives of General Psychiatry*, v. 42, n. 2, p. 187-196, 1985.
- BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY, Division of Clinical Psychology. *Position Statement on the Classification of Behaviour and Experience in Relation to Functional Psychiatric Diagnoses*. Leicester, 2013.
- COOPER, John E. et al. *Psychiatric Diagnosis in New York and London*. London: Oxford University Press, 1972.
- COSGROVE, Lisa; KRIMSKY, Sheldon. A comparison of DSM-IV and DSM-5 panel members' financial associations with industry. *PLoS Medicine*, v. 9, n. 3, 2012.
- DECKER, Hannah S. *The Making of DSM-III: A Diagnostic Manual's Conquest of American Psychiatry*. New York: Oxford University Press, 2013.
- FEIGHNER, John P. et al. Diagnostic criteria for use in psychiatric research. *Archives of General Psychiatry*, v. 26, n. 1, p. 57-63, 1972.
- FRANCES, Allen. *Saving Normal*. New York: William Morrow, 2013.
- HEALY, David. *The Antidepressant Era*. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
- HORWITZ, Allan V. *Creating Mental Illness*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
- HORWITZ, Allan V.; WAKEFIELD, Jerome C. *The Loss of Sadness*. New York: Oxford University Press, 2007.
- JOHNSTONE, Lucy; BOYLE, Mary et al. *The Power Threat Meaning Framework*. Leicester: British Psychological Society, 2018.
- KERNBERG, Otto F. *Borderline Conditions and Pathological Narcissism*. New York: Jason Aronson, 1975.
- KIRK, Stuart A.; KUTCHINS, Herb. *The Selling of DSM: The Rhetoric of Science in Psychiatry*. New York: Aldine de Gruyter, 1992.
- KLERMAN, Gerald L. The evolution of a scientific nosology. In: SHERSHOW, J. C. (org.). *Schizophrenia: Science and Practice*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- KRUEGER, Robert F. et al. Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. *Psychological Medicine*, v. 42, n. 9, p. 1879-1890, 2012.
- LANE, Christopher. *Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness*. New Haven: Yale University Press, 2007.
- LINGIARDI, Vittorio; McWILLIAMS, Nancy (orgs.). *Psychodynamic Diagnostic Manual — PDM-2*. 2. ed. New York: Guilford Press, 2017.
- MAYES, Rick; HORWITZ, Allan V. DSM-III and the revolution in the classification of mental illness. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, v. 41, n. 3, p. 249-267, 2005.
- OPD TASK FORCE. *Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning*. Göttingen: Hogrefe, 2008.
- ROSENHAN, David L. On being sane in insane places. *Science*, v. 179, n. 4070, p. 250-258, 1973.
- SPITZER, Robert L.; ENDICOTT, Jean; ROBINS, Eli. Research Diagnostic Criteria: rationale and reliability. *Archives of General Psychiatry*, v. 35, n. 6, p. 773-782, 1978.
- WHITAKER, Robert. *Anatomy of an Epidemic*. New York: Crown, 2010.
- WILSON, Mitchell. DSM-III and the transformation of American psychiatry: a history. *American Journal of Psychiatry*, v. 150, n. 3, p. 399-410, 1993.